BONUS 2

6 Rotasyon Başlangıç Rehberi

Nöro, Göğüs, Batın, Kas-İskelet, Pediatri ve Girişimsel/Meme: her rotasyonun ilk gününde bilmeniz gerekenler, en sık 10 tetkik, tipik hatalar ve ilk hafta kontrol listesi.

İçindekiler

Bu rehber nasıl kullanılır

Rotasyon 1 · Nöroradyoloji

Rotasyon 2 · Göğüs radyolojisi

Rotasyon 3 · Batın radyolojisi

Rotasyon 4 · Kas-iskelet radyolojisi

Rotasyon 5 · Pediatrik radyoloji

Rotasyon 6 · Girişimsel radyoloji ve meme

Her rotasyonun son günü

Sonraki adım

BAŞLARKEN

Bu rehber nasıl kullanılır

Yeni bir rotasyona başlamadan önceki akşam ilgili bölümü okuyun: 15–20 dakika yeterlidir.

> *Rotasyonun ilk haftası en çok şeyin öğrenildiği, ama en çok da kaybolunduğu haftadır. Bu rehber «nereden başlayacağım?» sorusunu sizin yerinize cevaplar.*

Her rotasyon bölümü aynı dört parçadan oluşur:

1. **İlk gün bilmeniz gerekenler** — servisin işleyişi, kimden ne öğrenmeniz gerektiği ve ilk okumanız gereken temel konular.
2. **En sık 10 tetkik** — o rotasyonda en çok karşınıza çıkacak tetkikler ve her birinde ilk bakacağınız nokta.
3. **Tipik hatalar** — 1. yıl asistanlarının en sık düştüğü tuzaklar ve nasıl kaçınılacağı.
4. **İlk hafta kontrol listesi** — hafta sonunda işaretleyebilmeniz gereken somut hedefler.

Her tetkikte aynı 4 adım

1 · HAZIRLA

Belirle (hasta, tetkik, tarih, protokol) · Kalite (teknik yeterlilik) · Yönlen (taraf, kesit, pencere/sekans).

2 · TARA

Her bölgeyi her seferinde aynı sırayla tarayın. İlk bulguda durmayın.

3 · TANIMLA

Doğru terimlerle (dansite / sinyal / ekojenite), lokalizasyon, boyut, sınır. Eski tetkik ve karşı tarafla karşılaştırın.

4 · ÖZETLE

Sonuç cümlesi, ayırıcı tanı, öneri. Acil bulguyu hemen bildirin.

Önemli

Her serviste protokoller, rapor şablonları ve bildirim yolları farklıdır. Bu rehberdeki listeler genel bir başlangıç noktasıdır; kendi servisinizin kuralını her zaman uzman hocanızdan öğrenin ve onu uygulayın.

ROTASYON 1

Nöroradyoloji

Beyin BT ve MR, omurga, baş-boyun. Nöbette en çok çağrılacağınız alanın temeli burada atılır.

İlk gün bilmeniz gerekenler

- Servisin **beyin BT okuma sırasını** öğrenin ve her tetkikte aynısını uygulayın: kanama, kitle etkisi ve orta hat, ventriküller ve sisternler, gri-beyaz cevher ayrımı, kemik penceresi, sinüsler ve mastoidler.
- **Pencereleri** doğru kullanın: beyin penceresi, inme penceresi (dar), kemik penceresi; gerektiğinde subdural pencere.
- **Akut inme** yolunu öğrenin: servisinizde hangi tetkiklerin (kontrastsız BT, BT anjiyografi, perfüzyon, DAG) hangi sırayla istendiği ve kimin bilgilendirileceği.
- MR sekanslarını tanıyın: T1, T2, FLAIR, DAG/ADC, SWI veya GRE, kontrastlı T1. Her birinde neyin parlak, neyin koyu olduğunu bilin.
- Omurga travmasında BT'nin rolünü ve hangi durumlarda MR istendiğini servis pratiğinden öğrenin.

En sık 10 tetkik

#	TETKİK	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
1	**Kontrastsız beyin BT (travma)**	Ekstraaksiyel kanama, kontüzyon, kafatası kırığı (kemik penceresi).
2	**Kontrastsız beyin BT (inme şüphesi)**	Kanama var mı; erken iskemi bulguları, hiperdens arter işareti.
3	**BT anjiyografi (baş-boyun)**	Büyük damar oklüzyonu, darlık, diseksiyon, anevrizma.
4	**Beyin MR (rutin)**	FLAIR'de beyaz cevher lezyonları, kitle, ödem; DAG'da kısıtlanma.
5	**DAG ile hızlı inme MR'ı**	DAG'da parlak, ADC'de koyu alan: akut enfarkt lehine.
6	**Kontrastlı beyin MR**	Kontrast tutulum paterni (halka, nodüler, leptomeningeal, dural).
7	**Servikal omurga BT**	Dizilim çizgileri, kırık, faset ilişkisi, prevertebral yumuşak doku.
8	**Lomber MR**	Disk hernisi, kanal ve foraminal darlık, kauda ekina basısı.
9	**Paranazal sinüs BT**	Mukozal kalınlaşma, hava-sıvı seviyesi, kemik destrüksiyonu, orbita.
10	**Temporal kemik / orbita BT**	Kemik bütünlüğü, kırık, yumuşak doku dansitesi, orbita içeriği.

Tipik hatalar

- Yalnızca beyin penceresine bakıp **kemik penceresini atlamak**; kafatası kırığını kaçırmak.
- İnce bir subdural hematomu, kafatası iç tablası boyunca uzanan yoğunluğu ancak geniş pencerede fark etmek; **subdural pencereye geçmemek**.
- DAG'da parlaklığı ADC'ye bakmadan akut enfarkt olarak yazmak (T2 parlama etkisi).
- Kitle etkisi ve orta hat şiftini sayısal ölçmeden «belirgin» diye tarif etmek.
- Eski tetkik varken karşılaştırma yapmamak.

İlk hafta kontrol listesi

- [ ] Beyin BT okuma sıramı ezbere ve her tetkikte aynı şekilde uyguluyorum.
- [ ] Beyin, inme, subdural ve kemik pencerelerini hızla değiştirebiliyorum.
- [ ] Servisin akut inme ve acil bildirim yolunu biliyorum.
- [ ] T1, T2, FLAIR, DAG/ADC ve SWI'yı görüntüden tanıyabiliyorum.
- [ ] En az 20 kontrastsız beyin BT'yi uzman hocamın raporuyla karşılaştırdım.
- [ ] Epidural, subdural ve subaraknoid kanamayı ayırt ederek tarif edebiliyorum.
- [ ] Cilt 03 · BT'nin beyin bölümünü ve Cilt 04 · MR'ın sekans bölümünü bir kez okudum.

ROTASYON 2

Göğüs radyolojisi

Akciğer grafisi, toraks BT ve BT pulmoner anjiyografi. En çok okunan tetkik burada.

İlk gün bilmeniz gerekenler

- **Akciğer grafisi** için sabit bir okuma sırası belirleyin: teknik (rotasyon, inspirasyon, penetrasyon), tüp ve kateterler, hava yolu, kalp ve mediasten, hiluslar, akciğer alanları, plevra ve sinüsler, diyafram altı, kemikler ve yumuşak doku.
- PA ile AP grafinin farkını bilin: AP'de kalp gölgesi büyük görünebilir; kalp boyutu yorumunu tekniğe göre yapın.
- Toraks BT'de **akciğer ve mediasten penceresini** ayrı ayrı, baştan sona tarayın.
- BT pulmoner anjiyografide kontrast zamanlamasının yeterliliğini önce değerlendirin; yetersizse bunu raporda belirtin.
- Yoğun bakım grafilerinde tüp, kateter ve dren pozisyonları ilk bakılacak şeydir.

En sık 10 tetkik

#	TETKİK	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
1	**PA akciğer grafisi**	Teknik yeterlilik, ardından sabit okuma sırası.
2	**Yatak başı AP grafi (yoğun bakım)**	Endotrakeal tüp, santral kateter, nazogastrik tüp, dren; pnömotoraks.
3	**Lateral akciğer grafisi**	Retrosternal ve retrokardiyak alan, posterior sinüsler, vertebralar.
4	**Kontrastsız toraks BT**	Nodül, konsolidasyon, buzlu cam, amfizem, plevral sıvı.
5	**Kontrastlı toraks BT**	Mediastinal ve hiler lenf nodları, kitle, vasküler yapılar.
6	**BT pulmoner anjiyografi**	Kontrast kalitesi; pulmoner arterlerde dolum defekti; sağ kalp zorlanması bulguları.
7	**Yüksek çözünürlüklü BT (YRBT)**	İnterstisyel patern: retikülasyon, bal peteği, buzlu cam, traksiyon bronşektazisi.
8	**Düşük doz tarama / nodül takibi**	Nodülün boyutu, yapısı ve önceki tetkike göre değişimi.
9	**Toraks BT anjiyografi (aort)**	İntimal flep, gerçek ve yalancı lümen, dal tutulumu.
10	**Plevral USG (gerekirse)**	Sıvının varlığı, miktarı ve septasyon olup olmadığı.

Tipik hatalar

- Belirgin bir bulgu görünce durmak; **ikinci bulguyu** (ör. kemik lezyonu, diyafram altı hava) kaçırmak.
- Yatarak çekilmiş grafide pnömotoraksın apeksten çok anterior ve bazalde toplanabileceğini unutmak.
- Kalp gölgesinin arkası, hiluslar ve apeksler gibi «gizli alanlara» bakmamak.
- Nodülü bulup önceki tetkikle karşılaştırmadan takip önerisi yazmak.

- Kontrast zamanlaması yetersiz bir BT pulmoner anjiyografiyi «emboli yok» diye raporlamak.

İlk hafta kontrol listesi

- [ ] Akciğer grafisi okuma sıram sabit; her grafide aynı sırayı izliyorum.
- [ ] Tüp ve kateter pozisyonlarını servisin beklediği şekilde raporlayabiliyorum.
- [ ] Pnömotoraks, plevral efüzyon, konsolidasyon ve atelektaziyi grafide ayırt edebiliyorum.
- [ ] Toraks BT'yi akciğer ve mediasten penceresinde ayrı ayrı tarıyorum.
- [ ] BT pulmoner anjiyografide önce kontrast kalitesine bakıyorum.
- [ ] En az 30 akciğer grafisini uzman raporuyla karşılaştırdım.
- [ ] Cilt 02 · Röntgen'in toraks bölümünü ve En Sık Bulgular Atlası'nın göğüs sayfalarını gözden geçirdim.

ROTASYON 3

Batın radyolojisi

Batın BT, USG, MR ve direkt grafi. Acil cerrahi kararlarına en çok katkı verdiğiniz rotasyon.

İlk gün bilmeniz gerekenler

- Batın BT için sabit tarama sırası: serbest hava ve serbest sıvı, solid organlar (karaciğer, dalak, pankreas, böbrekler, sürrenaller), safra yolları, barsaklar ve mezenter, damarlar, lenf nodları, pelvis, kemikler, akciğer bazalleri.
- **Kontrast fazlarını** tanıyın (arteriyel, portal venöz, gecikmiş) ve hangi klinik soruda hangi fazın istendiğini servis protokolünden öğrenin.
- Serbest havayı aramak için akciğer veya geniş pencereye geçmeyi alışkanlık haline getirin.
- Batın USG'de sağ üst kadran, böbrekler ve pelvisin standart kesitlerini öğrenin.
- Akut batında acil bildirilecek bulguların (serbest hava, aktif kanama, iskemi bulguları, kapalı ans obstrüksiyonu gibi) servisinizdeki bildirim yolunu öğrenin.

En sık 10 tetkik

#	TETKİK	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
1	**Kontrastlı batın-pelvis BT (portal venöz)**	Serbest hava, serbest sıvı, solid organlar, barsak duvarı.
2	**Kontrastsız BT (taş protokolü)**	Üriner sistemde taş, hidronefroz, perirenal yağ dokusu.
3	**Batın USG (sağ üst kadran)**	Safra taşı, duvar kalınlığı, perikolesistik sıvı, safra yolu çapı.
4	**Üriner sistem USG**	Hidronefroz, böbrek boyutu ve parankimi, mesane.
5	**Ayakta direkt batın grafisi**	Diyafram altı serbest hava, hava-sıvı seviyeleri, barsak çapları.
6	**Apandisit şüphesinde BT veya USG**	Apendiks çapı, duvar, çevre yağ dokusu, apendikolit, apse.
7	**Travma BT**	Solid organ yaralanması, aktif kontrast kaçışı, serbest sıvı.
8	**Karaciğer dinamik BT/MR**	Lezyonun fazlara göre kontrastlanma davranışı.
9	**MRKP**	Safra yollarında dolum defekti, darlık, pankreatik kanal.
10	**Pelvik USG / MR**	Over ve uterus yapıları, serbest sıvı, kitle.

Tipik hatalar

- Yalnızca yumuşak doku penceresinde bakıp **serbest havayı** kaçırmak.
- Ana bulguya odaklanıp **akciğer bazallerini** ve kemikleri taramamak.
- Böbrek taşı bulup diğer tarafı ve mesaneyi değerlendirmeden bitirmek.
- Apandisit sorulan tetkikte alternatif tanıları (divertikülit, over patolojisi, üreter taşı) aramamak.
- Kontrast fazını belirtmeden lezyon tarif etmek.

İlk hafta kontrol listesi

- [ ] Batın BT tarama sıram sabit ve her tetkikte aynı.
- [ ] Arteriyel, portal venöz ve gecikmiş fazı görüntüden tanıyabiliyorum.
- [ ] Serbest hava için her tetkikte geniş pencereye geçiyorum.
- [ ] Sağ üst kadran USG'nin standart kesitlerini alabiliyorum.
- [ ] Akut batındaki acil bildirim yolunu biliyorum.
- [ ] En az 15 batın BT'yi uzman hocamın raporuyla karşılaştırdım.
- [ ] Cilt 03 · BT'nin batın bölümünü ve Cilt 05 · USG/POCUS'un sağ üst kadran bölümünü okudum.

ROTASYON 4

Kas-iskelet radyolojisi

Travma grafileri, eklem MR'ı ve kemik lezyonları. Sistematik bakmayan en kolay kırığı kaçırır.

İlk gün bilmeniz gerekenler

- **Her travma grafisinde en az iki dik düzlem** gerektiğini ve tek düzlemin kırığı gizleyebileceğini unutmayın.
- Kemik grafisi okuma sırası: korteks bütünlüğü, eklem dizilimi, eklem aralığı, kemik dokusu (dansite ve yapı), yumuşak doku (şişlik, yağ yastıkçıkları, hava).
- Kırığı tarif etme sırasını öğrenin: kemik ve bölge, kırık hattının yönü, parça sayısı, deplasman ve açılanma, eklem tutulumu.
- Eklem MR'ında temel sekansları (yağ baskılı PD/T2, T1) ve hangi yapının hangi sekansta en iyi görüldüğünü öğrenin.
- Kemik lezyonunda sistematik yaklaşım: yer, sınır (geçiş zonu), periost reaksiyonu, matriks, yumuşak doku bileşeni.

En sık 10 tetkik

#	TETKİK	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
1	**El-bilek grafisi**	Distal radius, skafoid, karpal dizilim.
2	**Ayak bileği grafisi**	Malleoller, mortis aralığı, talus.
3	**Kalça ve pelvis grafisi**	Femur boynu korteksi, pelvik halka bütünlüğü.
4	**Omuz grafisi**	Humerus başı ile glenoid ilişkisi, kırık, çıkık.
5	**Diz grafisi**	Tibia platosu, efüzyon, eklem aralığı.
6	**Diz MR**	Menisküsler, çapraz bağlar, kemik iliği ödemi, kıkırdak.
7	**Omuz MR**	Rotator manşet tendonları, labrum, biseps tendonu.
8	**Travma BT (pelvis, omurga, eklem içi kırık)**	Kırık hattının uzanımı, parça sayısı, eklem yüzeyi.
9	**Lomber / torakal omurga grafisi**	Vertebra yüksekliği, dizilim, pedikül bütünlüğü.
10	**Kemik lezyonu değerlendirmesi (grafi, BT veya MR)**	Geçiş zonu, periost reaksiyonu, matriks, yumuşak doku bileşeni.

Tipik hatalar

- Tek bir kırığı bulup **ikinci kırığı** veya eşlik eden çıkığı aramamak.
- Skafoid ve femur boynu gibi **gizli kalabilen kırıklarda** grafi normalse ileri tetkik veya takip önerisini düşünmemek.
- Yumuşak doku bulgularını (yağ yastıkçığı belirtisi, eklem efüzyonu) değerlendirmemek.

- Omuz grafisinde posterior çıkığı tek düzlemde atlamak.
- Kemik lezyonunu tek kelimeyle («litik») bırakıp sistematik tarif etmemek.

İlk hafta kontrol listesi

- [ ] Her travma grafisinde iki düzlemi kontrol ediyorum.
- [ ] Kemik grafisi okuma sıramı (korteks, dizilim, eklem, kemik, yumuşak doku) uyguluyorum.
- [ ] Kırığı servisin beklediği sırayla tarif edebiliyorum.
- [ ] Diz MR'ında menisküs ve çapraz bağları sekans sekans değerlendirebiliyorum.
- [ ] Kemik lezyonu için sistematik yaklaşımı bir vakada baştan sona uyguladım.
- [ ] En az 30 travma grafisini uzman raporuyla karşılaştırdım.
- [ ] Cilt 02 · Röntgen'in kas-iskelet bölümünü ve Görüntü Yorumlama Rehberi'ndeki ilgili kontrol listesini gözden geçirdim.

ROTASYON 5

Pediatrik radyoloji

Çocuk küçük bir yetişkin değildir: farklı anatomi, farklı hastalıklar ve radyasyona daha fazla özen.

İlk gün bilmeniz gerekenler

- **Radyasyon koruma ilkesi** çocukta önceliklidir: mümkünse radyasyonsuz yöntem (USG, MR) tercih edilir; BT gerekiyorsa servisin pediatrik protokolü kullanılır.
- Büyüme plakları, ossifikasyon merkezleri ve yaşla değişen normal görünümler kırıkla karışabilir; şüphede **karşı tarafla karşılaştırma** ve atlas kullanımı servise göre değerlendirilir.
- Pediatride USG'nin geniş kullanımını bilin: invajinasyon, apandisit, pilor, kalça ve kraniyal USG gibi.
- Çocukta açıklanamayan kırık, farklı evrede kırıklar veya öyküyle uyumsuz bulgular gördüğünüzde servisin **çocuk koruma bildirim yolunu** uzman hocanızla birlikte izleyin.
- Sedasyon ve hazırlık gerektiren tetkiklerin servis içindeki işleyişini öğrenin.

En sık 10 tetkik

#	TETKİK	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
1	**Çocuk akciğer grafisi**	Teknik, timus gölgesi, konsolidasyon, hava hapsi, yabancı cisim.
2	**Batın USG (karın ağrısı)**	Apendiks, invajinasyon, serbest sıvı, lenf nodları.
3	**Dirsek grafisi**	Yağ yastıkçıkları, ossifikasyon merkezleri, suprakondiler kırık.
4	**Ön kol ve el bilek grafisi**	Torus ve yeşil ağaç kırıkları, büyüme plağı.
5	**Kalça USG (bebek)**	Asetabulum ve femur başı ilişkisi, servisin ölçüm yöntemi.
6	**Üriner sistem USG**	Hidronefroz, böbrek boyutu, mesane duvarı.
7	**Kraniyal USG (yenidoğan)**	Ventrikül boyutu, kanama, parankim ekojenitesi.
8	**Pilor USG**	Pilor kas kalınlığı ve kanal uzunluğu (servis kriterlerine göre).
9	**Direkt batın grafisi**	Barsak gaz dağılımı, obstrüksiyon, yabancı cisim.
10	**Kontrastsız beyin BT (travma)**	Kanama, kırık; endikasyonun servis kurallarına uygunluğu.

Tipik hatalar

- Normal büyüme plağını veya ossifikasyon merkezini **kırık sanmak**, ya da tersini.
- Dirsek grafisinde yağ yastıkçığı bulgusunu görüp gizli kırığı düşünmemek.
- Normal timus gölgesini mediastinal kitle olarak yorumlamak.
- USG ile cevaplanabilecek bir soruda refleks olarak BT önermek.
- Yaşa uymayan veya öyküyle uyumsuz bulguyu yalnızca tarif edip bildirim yolunu düşünmemek.

İlk hafta kontrol listesi

- [ ] Servisin pediatrik BT protokolünü ve radyasyon koruma kurallarını biliyorum.
- [ ] Dirsek grafisinde ossifikasyon merkezlerinin sırasını ve yağ yastıkçıklarını değerlendirebiliyorum.
- [ ] Torus, yeşil ağaç ve büyüme plağı kırıklarını tarif edebiliyorum.
- [ ] Apendiks ve invajinasyon için batın USG'sine en az birkaç kez eşlik ettim.
- [ ] Çocuk koruma bildirim yolunu uzman hocamdan öğrendim.
- [ ] Normal timus, normal büyüme plağı ve normal varyantların örneklerini gördüm.
- [ ] Cilt 05 · USG/POCUS ve Cilt 02 · Röntgen'in ilgili bölümlerini gözden geçirdim.

ROTASYON 6

Girişimsel radyoloji ve meme

İki farklı dünya, ortak bir kural: işlem öncesi hazırlık ve görüntünün doğru dille raporlanması.

İlk gün bilmeniz gerekenler

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

- İşlem öncesi kontrol: endikasyon, önceki görüntüler, onam, servisin istediği laboratuvar ve ilaç sorgulaması (kararı uzman hocanız verir).
- Steril alan kuralları, radyasyon koruma (kurşun önlük, tiroid koruyucu, mesafe, süre) ve dozimetre kullanımı.
- En sık işlemleri tanıyın: USG veya BT eşliğinde biyopsi, apse ve sıvı drenajı, perkütan nefrostomi, santral venöz erişim, anjiyografi.
- İşlem sonrası hasta takibinde servisin kontrol listesini öğrenin.

MEME RADYOLOJİSİ

- Mamografinin standart görüntülerini (CC ve MLO) tanıyın; her iki memeyi simetrik olarak karşılaştırın.
- Raporlamada **standart sınıflama sistemini** ve servisinizin kullandığı terminolojiyi öğrenin; kategoriyi ve öneriyi birlikte yazın.
- Meme USG'de kist ile solid lezyonu ayırt eden temel özellikleri bilin: şekil, sınır, iç yapı, arka akustik özellikler.
- Önceki mamografilerle karşılaştırma meme radyolojisinde özellikle önemlidir.

En sık 10 tetkik ve işlem

#	TETKİK / İŞLEM	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
1	**Tarama mamografisi**	Simetri, kitle, kalsifikasyon, yapısal distorsiyon; önceki tetkikle karşılaştırma.
2	**Tanısal mamografi**	Klinik bulgunun yeri; ek görüntü gereksinimi.
3	**Meme USG**	Kist mi solid mi; şekil, sınır, oryantasyon, arka akustik özellik.
4	**USG eşliğinde meme biyopsisi**	Hedef lezyon, iğne yolu, örnek yeterliliği.
5	**USG eşliğinde tiroid veya lenf nodu biyopsisi**	Hedef, çevre damarlar, güvenli yol.
6	**BT eşliğinde biyopsi**	Hedef ile güvenli iğne yolu; plevra ve damarlarla ilişki.
7	**Apse / sıvı drenajı**	Koleksiyonun boyutu, içeriği, güvenli erişim yolu.
8	**Perkütan nefrostomi**	Hidronefroz derecesi, böbreğe erişim yolu.
9	**Santral venöz erişim / port**	Damar açıklığı (USG), uç pozisyonu (skopi veya grafi).

#	TETKİK / İŞLEM	İLK BAKACAĞINIZ NOKTA
10	**Tanısal anjiyografi**	Erişim yeri, damar anatomisi, darlık veya kanama odağı.

Tipik hatalar

- İşlem öncesi önceki görüntüleri incelemeden işleme girmek.
- Radyasyon koruma ekipmanını ve dozimetreyi ihmal etmek.
- Mamografide tek memeye bakıp **simetri karşılaştırması** yapmamak.
- Meme raporunda kategori yazıp net bir öneri yazmamak.
- İşlem notunda kullanılan yöntem, örnek sayısı ve komplikasyon olup olmadığını belirtmemek.

İlk hafta kontrol listesi

- [ ] Servisin işlem öncesi kontrol listesini biliyorum ve uyguluyorum.
- [ ] Radyasyon koruma ekipmanımı ve dozimetremi her işlemde kullanıyorum.
- [ ] En az 3 USG eşliğinde işleme eşlik ettim ve adımlarını not aldım.
- [ ] CC ve MLO görüntülerini tanıyor, iki memeyi simetrik karşılaştırıyorum.
- [ ] Meme raporlamasındaki standart kategorileri ve önerileri öğrendim.
- [ ] Meme USG'de kist ile solid lezyonu tarif edebiliyorum.
- [ ] Cilt 05 · USG/POCUS'u ve Cilt 06 · Çoklu Modalite Vakaları'ndaki ilgili vakaları gözden geçirdim.

KAPANIŞ

Her rotasyonun son günü

Bir rotasyondan ötekine geçerken 20 dakikalık bir kapanış, öğrendiklerinizi kalıcı hale getirir.

1. **Kontrol listesine dönün.** İşaretleyemediğiniz maddeleri bir sonraki rotasyonun ilk haftasına not edin.
2. **En çok zorlandığınız 5 tetkiki** Pratik Defteri'ne yazın: neyi kaçırdınız, neden kaçırdınız, bir dahaki sefere ne yapacaksınız.
3. **Uzman hocanızdan kısa geri bildirim isteyin:** «Bu rotasyonda neyi daha iyi yapmalıyım?»
4. **Sonraki rotasyonun bölümünü** bu rehberden bir kez okuyun.
5. **12 Haftalık Rotasyon Çalışma Programı'nda** sıradaki haftayı yeni rotasyonunuza göre uyarlayın.

> **Altın kural**
>
> Her rotasyonda aynı soruyu sorun: «Nöbette bu alandan gelen bir tetkiki tek başıma güvenle okuyabilir miyim?» Cevap «henüz değil» ise, eksik olanı kontrol listesine ekleyin.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Şimdi şu anki rotasyonunuzun bölümünü açın ve ilk hafta kontrol listesini yazdırın.

Ardından **Vizitte Vaka Sunumu Şablonları**'na geçin: rotasyonda gördüğünüz vakaları vizitte 60 veya 120 saniyede nasıl sunacağınızı orada bulacaksınız.